26.855.041-0

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Eidan Joseph Pérez Lazcano			Sexo	F	M	X
Fecha Nacimiento	3/6/2019	Edad actual	4 años	9 meses		País natal:	Chile
Domicilio actual:	Lozerforos del Inca #735			Teléfono	+56964479875		
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☐ lee ☐ escribe ☐				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☐ lee ☐ escribe ☐				
Escolaridad actual:	Pre-Kinder	Establecimiento	Liceo Mixto Básica S.F				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 19/03/24	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Angie Lazcano H.	Nombre:
Relación con el/la estudiante: madre	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 19/03/24	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Beatriz Sánchez	Nombre:
Rol/cargo: Educadora Diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

La pronunciación oral es inadecuada. Y presenta dificultades para comprender.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☑ Sí **(especificar)**

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología: /	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009

Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☒ cesárea (señalar motivo) Programada

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO	Peso: 3.750	Talla: 50

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

La madre sufrio de diabetes gestacional.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	[✓ No]	Traumatismos	Sí	[✓ No]	Encefalitis	Sí	[✓ No]
Obesidad	Sí	[✓ No]	Intoxicación	Sí	[✓ No]	Meningitis	Sí	[✓ No]
Fiebre alta	Sí	[✓ No]	Enfermedad respiratoria	Sí	[✓ No]	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	[✓ No]	Asma	Sí	[✓ No]			
Hospitalizaciones	Sí	[✓ No]	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	[✓ Sí]	No	Vacunas	[✓ Sí]	No

Observaciones:

no presentó dificultades importantes en su primer año de vida.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 5 m	Se sienta sólo/a: 7 m	Camina sin apoyo: 1a 6 m
Primeras palabras: 3 años	Primeras frases: 4 años	Se viste solo/a: 4 años

Controla esfínter vesical Diurno: 3a Nocturno: 3 años	Controla esfínter anal Diurno: 3a Nocturno: 3 años

Observaciones:

se viste solo con supervisión de algún adulto.

En su actividad motora general se aprecia:
[✓ normal] ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:
☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	[✓ Sí]	No	Caídas frecuentes	Sí	[✓ No]	Dominancia lateral	[✓ Sí]	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	[✓ Sí]	No	Prensión	[✓ Sí]	No	Pinza	[✓ Sí]	No
Ensarta	[✓ Sí]	No	Dibuja	[✓ Sí]	No	Escribe	[✓ Sí]	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	[✓ Sí]	No	Manipula y Explora objetos	[✓ Sí]	No
Demanda objetos y compañía	[✓ Sí]	No	Comprende prohibiciones	[✓ Sí]	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	[✓ Sí]	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	[✓ Sí]	No

Observaciones:

Sin observaciones.

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	[✓ Sí]	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	[✓ Sí]	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	[✓ No]	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	[✓ Sí]	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	[✓ No]	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	[✓ Sí]	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	[✓ No]	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	[✓ No]
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	[✓ Sí]	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	[✓ No]
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	[✓ No]	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	[✓ No]
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	[✓ No]	La pronunciación oral es adecuada	Sí	[✓ No]
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	[✓ No]	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	[✓ No]

Observaciones: sin dificultades relevantes, solo su pronunciación oral es inadecuada.

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☑ oral ☑ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	[✓ Sí]	No	Emite/produce frases	[✓ Sí]	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	[✓ Sí]	No	Relata experiencias	Sí	[✓ No]
Emite palabras/produce señas	[✓ Sí]	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	[✓ No]

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones simples	[✓ Sí]	No
Identifica personas	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	[✓ No]
Comprende conceptos abstractos	[✓ Sí]	No	Sigue instrucciones grupales	[✓ Sí]	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	[✓ Sí]	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	[✓ Sí]	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): no manifestó pérdida del Lenguaje.

Observaciones: sin observaciones relevantes.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	[✓ Sí]	No	Se relaciona en forma colaborativa	[✓ Sí]	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	[✓ Sí]	No	Respeta normas sociales	[✓ Sí]	No
Participa en actividades grupales	[✓ Sí]	No	Respeta normas escolares	[✓ Sí]	No
Opta por trabajo individual	[✓ Sí]	No	Muestra sentido del humor	[✓ Sí]	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	[✓ No]	Movimientos estereotipados	Sí	[✓ No]
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	[✓ No]	Pataletas frecuentes	Sí	[✓ No]

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☑ natural ☐ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada

Observaciones: sin observaciones.

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	[✓ Sí]	No	Trastorno motor	Sí	[✓ No]
Epilepsia	Sí	[✓ No]	Problema bronco-respiratorio	[✓ Sí]	No
Problemas cardiacos	Sí	[✓ No]	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	[✓ No]
Paraplejia	Sí	[✓ No]	Trastorno emocional	Sí	[✓ No]
Pérdida auditiva	Sí	[✓ No]	Trastorno conductual	Sí	[✓ No]
Pérdida visual	Sí	[✓ No]	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique): Está en tratamiento con fluticasona inhalador por bronquitis, presenta adenoides.

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☑ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme:

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☑ despierta de buen humor

Duerme: ☑ solo ☐ acompañado (Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☑ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones: Por las noches despierta por los episodios de obstrucción nasal.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Angie Lazcano	Madre	45	Técnico	Dueña de Casa.
2. César Pérez	Padre	44	Superior	Repartidor.
3. Gabriel Pérez	hermano	11	5°B.	Estudiante.
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Padre presenta trombosis; ambos padres con hipertensión, hipotiroidismo. hermano mayor presenta DIR.

Observaciones:

sin observaciones relevantes.

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	4 años	Asistió a jardín infantil	Sí	[✓ No]
Nº de colegios en que ha estudiado	1	Modalidad de enseñanza [✓ Regular] Especial Técnica :		

Motivo de los cambios: —

Ha repetido curso/s	Sí	[✓ No]	Curso(s)	Motivo:	

Situación actual

Nivel/curso actual	Pre K		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	[✓ No]	**Dificultad para participar**	Sí	[✓ No]	**Conducta disruptiva**	Sí	[✓ No]
Asiste regularmente	[✓ Sí]	No	Asiste con agrado	[✓ Sí]	No	Apoyo familiar en tareas	[✓ Sí]	No	Amigos (as)	[✓ Sí]	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) ……………………………………

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra ……………………………………

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra ……………………………………
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☑ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☐ tiempo libre ☐ otro(s)……………………

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☑ madre ☑ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales ……………………………………

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☑ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

a la edad de 3 años se rompió la cabeza, le pusieron puntos.

- Utiliza inhalador con 1 puf antes de dormir fluticasona

- asistió a escuela de Lenguaje.